

CETOACIDOSIS DIABETICA

MEDIDAS GENERALES

- Dieta absoluta primeras horas, luego agua de confort.
- 2 vías periféricas. Control TA, FC, SatO₂ y glucemia/h primeras 6h.
- Analítica completa ingreso: Hemograma, Bioquímica con iones (Na, K, P, Ca, Mg), Coagulación, Láctico, ECG, RxTx, Sedimento orina. Cultivos si fiebre.
- C. cetónicos en orina: 1h (1ª 6h) después cada 2h
- Gasometría venosa o art con iones: Na, K, Ca, P. Cada 2h primeras 6h → 6-12h: /4h → >12h: /8h. Espaciar según controles.
- **No** se recomienda corrección con **bicarbonato**. Considerarlo si pH<7,1 o Bic <5. → Bic 50 o 100 mEq (50-100ml 1M (si via central) o 250-500ml 1/6M (Si periférica)).
- Profilaxis antitrombótica: Hibor 3500 o Clexane 40mg/24h sc

INSULINOTERAPIA

- **No** recomendado bolo inicial iv. Especialmente si K< 3,5
- **Perfusión: 100 UI Insulina +100 cc SF** a (0,1 ml/Kg/h) → para 70Kg: 7 m/h
 - Si no disminuye glucemia >50mg/h → ↑ 2 ml/h
 - Si disminuye glucemia < 250mg/dL → ↓ 2ml/h hasta gluc <200
 - Añadir glucosados y manejo según Fluidoterapia →
 - Si gluc <200 mg/gl
 - Ir disminuyendo Velocidad hasta dejar 1ml/h
- **NO** se suspende perfusión de Insulina hasta resolución de CAD e iniciada Insulina sc y dieta oral. Si gluc bajas poner glucosados según indicaciones.

FLUIDOTERAPIA

- Solo **Fisiológico**:
 - SSF0,9% 1000ml en 1ªh → 1 litro (2ªh) → 1 litro en 2h (3ª y 4ªh)
 - SSF0,9% 500ml/4h a partir de la 4ªh. 83ml/h
 - SSF0,9%/8h a partir de la 8ªh. 62 ml/h
- Comenzar con **Glucosados** cuando glucemias <250 mg/dl:
 - SG5% a 63 ml/h si Gluc>200. ↑ 84ml/h si Gluc<150
 - Si sigue ↓gluc aumentar a siguiente concentración:
 - SG10% si Gluc <120-150.
 - SG 20% si Gluc <120.

TRASTORNOS IONICOS

ClK	• Si K< 3,5 mEq/L Administrar ClK. 20 mEqClK en cada SF0,9% 500ml. • K 3,5-5,5 mEq/L 10 mEqClK en cada suero 500ml. • K>5,5 mEq/L No administrar y esperar siguientes analíticas. ○ V periférica: max 20 ClK+500 cc SF en 2h. ○ V central: max 40 mEq ClK + 100cc SF en 1h.	Na	• Corregirlo por la glucemia. • Si Na>150 mg/dL. Bajar suero fisiológico o administrar SG o SF0,45%. Si tolera agua beber.	P / Ca /Mg	Si déficit reponer con la sueroterapia. 1-2 amp de: • Fosfato Monosódico • Gluconato Cálcico • Sulfato Mg.
------------	---	-----------	--	-------------------	--

RESOLUCION

Criterios de resolución	Inicio Insulina sc	Otros	Corrección glucemias
pH>7,3 Bic >15 mEq/L Glucemia < 250mg/dL C cetónicos orina ≤ 2+.	0,4-0,8 UI/Kg: Para 70Kg : poner 30 UI sc: ○ 50%: Basal → 20 UI (Lantus) ○ 50%: rápida /4h → 10 UI rápida sc y corregir según Gluc/4h	○ Iniciar tolerancia oral dieta diabético ○ Levantar a sillón ○ Suspender Insulina iv tras 1h primera dosis sc.	Gluc/4h. Según glucemias: ○ >250: 15 UI ○ 250-200: 10UI ○ 150-200: 5 UI ○ <150: Nada

OBSERVACIONES

- Se miden 3 C cetónicos:
 1. **B-Hidroxibutarato (BHB)** + importante. **No** se detecta en orina. Se puede medir en **sangre**. Además cuando mejora aumenta la conversión a AAA lo que puede hacer que los c cetónicos aumenten en orina a pesar de que se esté resolviendo el cuadro.
 2. **Ac acetoacético (AAA)**
 3. **Acetona** (No es un ácido). El que se detecta en orina. Indicadores retardados de la resolución de la CAD.
- **CAD euglucémica**: Pacientes tratados con los ISGLT-2. Presentan acidosis pero glucemias más bajas. Se trata igual.
- Dx Diferencial cuerpos cetónicos en orina: Ayuno, embarazo, Alcoholismo.
- **Estado hiperosmolar**: Se presenta con Gluc >600 pero menos acidosis. Similar manejo pero dar preferencia a hidratación.

POTASIO	Grandes Volúmenes (500ml)				Pequeño (100ml)	
	Periférica		Central		Central	
	Max	Rec	Max	Rec	Max	Rec
Concentración (mEq/Vol)	30	20		50	20 mEq + 100ml 40 mEq + 100ml	
Velocidad (mEq/h)	20	10	40	20	40	20
Dosis diaria (mEq/d)	150		300		Hasta 60mEq/3h	

	Ingreso	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h
Gasos Na, K, Ca, P	Completa	X	X		X		X				X
C C orina		x	x	x	x	x	x		x		x
Glucemia		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Insulina PC		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
SSf0,9%		1000ml	1000ml	500ml	500ml	500ml	500ml	500ml			
SG5%								500ml			

